

· 书刊评介 ·

评《处方药物相互作用简明手册》

(胡长鸿等编写, 浙江科学技术出版社, 1987年7月第1版)

山东省文登整骨医院(264400) 解 斌 隋 成

由胡长鸿教授等编写的《处方药物相互作用简明手册》一书, 是根据近几年国内外10余种有关专著编译而成。全书共记载常用药物500余种, 重点记载药物进入机体后由于药效学与药动学机制所产生的药物相互作用。作者们收集了大量的药学资料, 是目前国内仅有的全面简要地阐述药物相互作用的专著, 颇能反映国内药物相互作用研究的新水平。适合各级医、药工作者学习和参考。该书对每一种药物, 均按作用增强、减弱和其它药物相互作用等条目分列叙述, 条例清晰而醒目, 便于查阅; 每条内容后面均注明引用文献, 便于读者进一步查阅原著。为便于检索, 书末附有中、英文索引。确是一本题材新颖、内容丰富、简明扼要、查阅方便、注重实用的好书, 对指导临床合理用药具有重要参考价值。但随着医药科学的日益发展, 拜读之后, 发现该书尚有一些不尽完善之处, 现提出供作者和读者参考。

一、内容欠妥方面

1. 32页第9~10行“苯妥英(钠)与巴比妥类(合用)可能改变苯妥英(钠)的血药浓度, 注意调整苯妥英(钠)的剂量。”此说含糊, 使读者无所适从。据报道^[1], 苯妥英钠与苯巴比妥长期合用(6周以上)大多数癫痫患者苯妥英钠达不到有效的血药浓度, 由于苯巴比妥可诱导肝微粒体酶而使苯妥英钠的血药浓度和药效显著降低, 致症状难以控制, 且副作用多。停用苯巴比妥后, 苯妥英钠的血药浓度普遍升高。另癫痫儿童长期合用此两药, 易致软骨病^[2]。因为两者均为药酶诱导剂, 可使体内维生素D代谢加速, 故两者不宜合用。

2. 32页第9行“苯妥英钠与下列药物合用”项下宜补充: 注射用苯妥英钠在含有葡萄糖的溶液中可形成沉淀或微小结晶, 在生理盐水中也形成微小结晶^[3]。

3. 125页14行“维拉帕米可显著升高地高辛血浓度, 但未见发生洋地黄中毒的报道。”此说欠妥。有人报道^[4], 在一组49例患者的研究中发现, 维拉帕米引起地高辛血浓度显著升高, 有7例出现典型的洋地黄

中毒症状; 还有人报道⁵, 2例心脏病人并用异搏定和地高辛后, 血清地高辛浓度明显上升, 并致中毒死亡。维拉帕米与地高辛合用, 发生洋地黄中毒的报道并非少见^[6~8], 不赘述。大量临床观察和实验证明⁹, 维拉帕米可影响地高辛清除和肝代谢, 两药联用可导致地高辛血药浓度增长60~80%, 总清除减低约30%, 还可增加患者对地高辛的易感性, 即使在正常剂量范围内, 也有导致地高辛中毒的危险。为此有人提出^[4], 两者联用时, 应将地高辛减少50%, 并对患者严密观察及进行地高辛监测。

4. 323页第12行“羧噻吩青霉素减弱下列药物的作用……妥布霉素”对此尚有争论。文献报道^[10], 青霉素类与妥布霉素联用, 有协同作用。还报道^[11], 羧噻吩青霉素合用妥布霉素被认为是目前治疗绿脓杆菌性脑膜炎的最佳方案之一。

5. 193页倒数5行“碳酸氢钠减少乙酰水杨酸的口服吸收……致血药浓度低于有效治疗水平。”对此尚有不同看法。有人认为^[12], 两者合用, 除可增加乙酰水杨酸的溶解度和溶解速率外, 尚可促进胃的排空, 使其迅速进入小肠而有利于吸收。小肠的面积大大超过胃, 且药物在小肠停留时间也较长, 大部分药物, 不论什么性质, 主要还是在小肠中吸收。有人给健康人口服乙酰水杨酸后, 发现只有10%经胃吸收, 其余部分则在小肠吸收。国外有的复方乙酰水杨酸片剂, 就是与碳酸氢钠或碳酸钙配伍的。还有人为此在血药浓度监测的基础上, 在病人治疗时作自身对照试验^[13], 结果发现合用碳酸氢钠0.5g/次, qid, 则可提高乙酰水杨酸的药浓度及疗效。有的风湿病患者, 服用乙酰水杨酸1g tid, 一月余, 临床效果不显, 血药浓度224 μg/ml, 加服碳酸氢钠0.5g/次, qid, 复测血药浓度为258.8 μg/ml, 临床症状均消失。

6. 224页倒数4行“氯噻嗪引起钾丢失而增强洋地黄的毒性, 需补钾盐以防洋地黄中毒”和229页第11行“(呋喃苯胺酸)引起钾丢失可加重洋地黄毒性, 需补钾”但近来国内外研究发现^[14], 应用氯噻嗪和

呋喃苯胺酸时,无需常规补钾,因为即使失钾也是少量,不致于引起低钾血症,而且常规补钾不一定能使血钾浓度达到正常水平。利尿药可引起心律失常,以前认为是缺钾所造成,但近年研究发现,镁缺乏是利尿药引起心律失常的主要因子,不管机体钾状态如何,补镁可以控制继发于排钾利尿药引起的心律失常。对35例心衰患者在使用排钾利尿药的同时,加用镁盐治疗也获佳效,且不出现低钾血症。还有人报道^[5],用噻嗪类利尿剂、呋喃苯胺酸和利尿酸等,可明显增加尿镁排泄,噻嗪类利尿剂在小剂量时即增加尿镁,长期应用可引起严重缺镁,而镁丢失可加重洋地黄中毒。

二、内容宜补充方面

1. 69页倒数2行“安定与下列药物合用”项下宜补充:安定与度冷丁合用,可引起呼吸停止;与阿米替林合用可造成肝脏损害;与维生素K合用可引起出血(安定有抗维生素K作用,对凝血过程有抑制作用)^[1]。

2. 125页第7行“下列药物增强地高辛的作用”项下宜补充:红霉素和四环素可增加地高辛血药浓度43~116%,甚至2倍^[17]。因为肠道内的细菌可参与地高辛在体内的代谢,对应用地高辛的患者,如并用抗菌药物,就会因改变肠道菌群而抑制地高辛的代谢,从而使其血药浓度显著升高。

3. 200页倒数2行“雷尼替丁与下列药物合用”项下宜补充:雷尼替丁可减少维生素B₁₂的吸收,长期应用可致维生素B₁₂缺乏;雷尼替丁可使利多卡因、心得安、美多心安的代谢减慢,作用增强^[18]。

4. 188页第7行“氨茶碱与下列药物合用”项下宜补充:保泰松、巴比妥类、甲磺丁脲可使氨茶碱代谢加快,疗效显著减弱^[19]。

5. 188页第16行“下列药物增强氨茶碱的作用”项下宜补充:磺胺甲基异噁唑与氨茶碱合用,由于前者的血清蛋白结合率高,在体内与氨茶碱争夺结合蛋白,从而使氨茶碱的体内游离浓度升高,作用显著增强^[1]。氯霉素与氨茶碱合用由于氯霉素能抑制肝脏药酶的活性,干扰氨茶碱在肝脏的代谢灭活,延缓其在体内的清除,从而使其血药浓度也显著升高^[20]。

6. 312页第8行“维生素B₁₂与下列药物合用”项下宜补充:维生素B₁₂可使林可霉素、四环素类失活达50%左右,使制霉菌素的抗真菌作用完全消失^[21]。

7. 314页倒数1行“下列药物减弱维生素C的作用”项下宜补充:维生素C与维生素K₃合用可发生氧化还原反应,维生素C失去电子被氧化成去氢抗坏

血酸,后者得到电子被还原成甲萘二酚,使两者作用均减弱或消失^[22]。

8. 317页第9行“下列药物减弱青霉素的作用”项下宜补充:青霉素G与氨茶碱、碳酸氢钠等碱性药物混合静滴,由于pH升高,使青霉素分解而失去抗菌活性。

9. 338页第7行“下列药物增强庆大霉素的作用”项下宜补充:庆大霉素与血浆蛋白的结合率为25~30%或更少,如与钙剂合用,可使其与血浆蛋白的结合进一步下降,从而使庆大霉素的活性和毒性均明显增强^[22]。

10. 359页第10行“下列药物减弱异烟肼的作用”项下宜补充:异烟肼分子中的肼基,能与钙、镁、铁等金属离子生成螯合物,影响异烟肼的吸收,使异烟肼的血药浓度下降^[23]。

11. 388页11行“自力霉素与下列药物合用”项下宜补充:自力霉素分子结构具有苯醌、乌拉坦及乙烯亚胺基三种有效基团,含醌式结构的药物与维生素C混合,易发生氧化还原反应,导致两者药效均降低。三磷酸腺苷注射液(内含抗氧剂亚硫酸氢钠)亦不宜与自力霉素合用,因亚硫酸根离子可使自力霉素分子中的醌式结构被还原,而使其作用失活^[1]。

12. 40页15行“γ-羟基丁酸钠与下列药物合用”,宜补充:本品与度冷丁同时静滴,可出现呼吸抑制,国内已有两者混合静滴(常用量)致死的报道^[24],故两者不宜同时静滴。

13. 145页12行“胺碘酮与下列药物合用”,宜补充:本品可使奎尼丁、普鲁卡因酰胺、利多卡因的血药浓度升高,应避免合用;与苯妥英钠合用能扭转室速,引起心脏停搏;与异搏定合用能增加房室传导阻滞;与硫氮萘酮合用可协同抑制窦房结功能,导致不同程度窦房结功能障碍和房室结传导阻滞,甚至引起心脏骤停。故两者不宜合用^[25]。

参 考 文 献

- [1] 冯春荣. 药学通报 1985; 20(5):261
- [2] 杨毓英等. 不合理用药分析200例. 上海科技出版社, 1986: 176
- [3] 刘国杰等译. 临床药物资料手册. 北京:人民卫生出版社, 1982:381
- [4] 田明海等. 新药与临床 1986; 5(6):375
- [5] 李景先. 中国医院药学杂志 1985; 5(12):512
- [6] 罗柱流. 中华内科杂志 1983; 22(9):564
- [7] 史常志等. 中华心血管杂志 1985; 13(1):19
- [8] 段宝祥等. 江苏医药 1986; (1):封3
- [9] 戚品一. 药学通报 1987; 21(9):516

- [10] 陈新谦等. 新编药理学. 第12版. 北京: 人民卫生出版社, 1985: 104
- [11] 刘泉林. 药学通报 1987; 22(9): 562
- [12] 王永铭. 新药与临床 1986; 5(2): 87
- [13] 张楠森等. 药学通报 1984; 19(1): 5
- [14] 张汉忠. 中国医院药学杂志 1988; 8(5): 205
- [15] 饶明道. 中级医刊 1988; 23(2): 47
- [16] 樊德厚. 中国医院药学杂志 1987; 7(2): 78
- [17] 李锡岩. 中国医院药学杂志 1984; 4(4): 24
- [18] 李绍平. 药学通报 1987; 22(8): 509
- [19] 范成德. 中国医院药学杂志 1985; 5(8): 337
- [20] 曲春华. 中国医院药学杂志 1987; 7(6): 243
- [21] 陆雪林等. 中国医院药学杂志 1985; 5(9): 401
- [22] 何龙海. 实用内科杂志 1984; 4(4): 216
- [23] 陈孝治. 药学通报 1986; 21(10): 604
- [24] 黄振东. 中国医院药学杂志 1987; 7(5): 237
- [25] 曹熙宇. 中级医刊 1985; 20(13): 43
- [26] 徐永昭. 中国医院药学杂志 1988; 8(5): 208

简 评 《 生 药 学 》

(郑学忠主编. 生药学. 人民卫生出版社, 1988年第1版)

广西南宁地区药品检验所 (530001) 梁文法

《生药学》是全国中等卫生学校教材,供三年制药剂士专业使用。该书系由1980年版全国中等卫生学校药剂士专业试用教材《中草药学》经较多的增补、修改而成,教材内容由原教材的上、中、下三篇改为上、下两篇,删掉了下篇方剂基本知识。在改篇的下篇中,又把原全为详述的生药改为详述和列表简述两类,使之编排更为合理。书后另编附录一生药学教学大纲和附录二生药学实验指导,便于抓住重点教学和学生掌握重点学习。故此,该书不失为一本较好的中专教材。但粗读后,发现尚有不足之处,提出以下几点意见,供再版时参考。

1. 本书部分生药来源与1985年版药典一部(下称药典)不符。全书共收载生药325种,有275种属药典收载的品种,但其中有54种来源与药典不符。在这些品种中,有47种药典收载的主流品种,本书仅收载其中部分,其余部分不收或作为附注说明。例如第84页的地榆,药典^[1]收载来源为蔷薇科植物地榆(*Sanguisorba officinalis* L.)或长叶地榆[*S. officinalis* L. var. *longifolia* (Berl.) Yü et Li]的干燥根。而本书只收前者,把后者放在附注中注解;另有7种药典不收载为主流品种,却收载为主流品种。如第147页的天花粉,本书收载葫芦科植物(1)括楼(*Trichosanthes kirilowii* Maxim.), (2)日本括楼(*T. japonica* Rgl.), (3)双边括楼(*T. uniflora* Hoo)等同属植物的干燥根,而药典^[2]仅收载前两种,也没有收载其同属植物。笔者认为,本书是在药典颁布施行期间,凡属药典收载的品种,都应按药典规定收载。

2. 本书第77页、79页和81页中的防己、山乌龟和

延胡索等,理化鉴别项下浓度单位仍用当量浓度“N”,这是不符药典规定的。中国药典从1985年版开始,已废除了以前长期使用的浓度单位“当量及其符号N”,已改用mol/L表示,因此本书再版时应按药典规定更正。

3. 全书有广防己等24种生药理化鉴别项下的薄层层析,都用了对照品作对照鉴别,但其中有20种描述不清楚,即只写出样品液的制备,没有提及,也没有写出对照品液的制备,而在展开图谱上却出现了对照品的斑点图谱,造成图文矛盾,看图时不易理解。建议应按药典规格化进行描述。

4. 在教学大纲上,须掌握的重点生药,在全书10大类中,除茎木类、皮类、花类外,其它7大类,每类均有1个品种不属药典收载而列为学生重点掌握。如第48页根和根茎类生药绵马贯众、第238页叶类生药三尖杉、第310页果实和种子类生药胖大海、第365页全草类生药铃兰、第374页藻菌类生药麦角、第392页其它植物类西黄蓍胶和第406页动物类犀角。笔者认为须重点掌握的生药应以药典收载的品种为宜。

5. 第44页“生物检定内容”不应编入“杂质检查”项内。因“生物检定”不是检查杂质,主要是检定药物效价的一种方法^[3]。应另列:九、生物检定或其它。

6. 提取方法不当:第52页广防己理化鉴别项:“取本品粉末0.2g,加乙醇2ml,加热提取(时时补充酒精)30分钟”,此法不当,因乙醇容易挥发,加热后,即会迅速挥发掉,建议改为回流提取法。

7. 与药典正名不符的品种:如第246页罗布麻、第249页颠茄、第334页王不留、第334页复盆子等,应